研修医向け · 20 分

心理的安全性トレーニングが医療を変える

参考文献

2026-05-15 · AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

ケース

症例:「言えなかった夜」

- 夜間緊急手術、麻酔導入直後
- 担当看護師が薬剤量の違和感に気づいた
- しかし先輩医師には言えなかった
- 術後に深刻な合併症が発覚した

「なぜ言えなかったのか」――この問いから始めよう

言えない職場で何が起きるか

- ミスに気づいても黙る
- 疑問があっても流す
- インシデントを「なかったこと」にする
- → ヒヤリハットが本番事故になる

心理的安全性とは

- **定義**: 対人リスクを取っても安全だと感じられるチームの共有信念（Edmondson 1999）
- 「批判される」「恥をかく」「報復される」の恐れなく発言できる状態
- **安心・ぬるさとは違う** — 挑戦・異議・ミス報告のしやすさ

PART 1

研究を読む

BMJ Open Quality 2025 — 概要

- **雑誌**: BMJ Open Quality、2025年5月
- **種類**: 質改善（QI）報告。対照群なし
- **対象**: ベトナム7病院の麻酔科専門職 112名
  - 麻酔看護師71名 / 麻酔科医41名
- **期間**: 18ヶ月
- **問い**: 構造化訓練でチームの発言・安全文化は変わるか

「難しい環境」の意味

実施上の障壁	論文の記述
権威勾配	階層的な文化
言語障壁	言語の壁
資金・運営	資金とロジスティクス

- これらの障壁がある中で実施できた点に意味がある

介入の設計

- **① eラーニング**：自己学習モジュール4本（自分のペースで）
- **② 2日間シミュレーション**：対面4回、危機対応・発言などのシナリオ訓練
- **③ 18ヶ月の追跡**：自己報告・観察・安全監査で変化を確認
- 設計原則:「コミュニケーションを技術として教える」

主要アウトカム：eラーニングのテスト

- **事前テストの正答率**：41%
- **事後**：89%（p<0.001）
- **変化**：+48ポイント
- 参加者の **93%以上** が「変化は持続可能」と回答（主観評価）
- 測ったのは**知識**であり、心理的安全性そのものではない

副次アウトカム

- **発言を含むコミュニケーションの変化** ：46〜63% が挙げた（自己報告・観察）
- **インシデント報告**：増加（検定はされていない）。報告ゼロのスタッフの割合は前年の半分に
- 職種別の結果は報告されていない

批判的吟味

- 対照群のないQI報告 → 因果は言えず、交絡を排除できない
- アウトカムは知識テストと自己報告が中心 → 過大評価のリスク
- 心理的安全性は、検証済みの尺度では測られていない
- ベトナム麻酔科という限定サンプル → 他施設への一般化は慎重に
- **それでも**: 権威勾配のある環境でも実施でき、前向きな変化が報告された点は参考になる

PART 2

何が変わるか

PART 2 · 何が変わるか

「性格」から「設計可能」へ

- 従来の通説: 心理的安全性 = リーダーの性格 or 組織文化の問題
- この研究が示唆すること: **訓練できる側面がある**（因果は未確定）
- 文化の違いへの懸念は大切。自分の現場で小さく試して確かめる

PART 2 · 何が変わるか

難しい環境で効いた、その意味

- 階層文化・言語の壁・資金の制約がある現場で実施された
- 日本の病院に当てはまるかは、試して確かめる段階
- **設計次第で変わりうる** ― これがこの論文の示唆

PART 2 · 何が変わるか

介入設計の要点

- eラーニングで知識を個人化 → **シミュレーションで行動を練習**
- 2日間の集中シミュレーションを4回実施
- 18ヶ月の追跡で、変化が続くかを確認

PART 3

自分のチームへ

PART 3 · 自分のチームへ

ペアワーク (3分)

あなたのチームの「心理的安全性の温度」を測ってみよう

1. 「最近、上司に疑問を声に出したことがあるか？」
2. 「インシデントを報告するとき、何が怖いか？」
3. → **1つ変えるとしたら、何を変えるか**

明日から使える 3 つのアクション

1. **朝のブリーフィングに問いを入れる**：「今日の懸念点は?」を1分
2. **インシデント報告を称賛する**：「報告してくれてありがとう」を大きく言う
3. **自分が先に間違いを認める**：リーダーのモデリングが最速の変化

まとめ

- 心理的安全性は **性格だけでなく、訓練できる側面がある**（示唆）
- eラーニング + 2日間シミュレーション → テスト正答率 41% → 89%
- 権威勾配のあるベトナムの7病院でも実施でき、前向きな変化が報告された
- 設計の鍵: コミュニケーションを **技術**として扱う

参考文献

1. Vu V, Buléon C, Le TA, et al. Changing minds, saving lives: how training psychological safety transforms healthcare. BMJ Open Quality 2025;14(2):e003186. https://doi.org/10.1136/bmjoq-2024-003186

2. Edmondson AC. Psychological safety and learning behavior in work teams. Adm Sci Q. 1999;44(2):350–383. https://doi.org/10.2307/2666999

参考文献